

Diagnostyka *różnicowa* CSBD

Wzmoczone zachowania seksualne mogą wynikać z 6 innych zaburzeń. Diagnoza CSBD jest „rozpoznaniem przez wykluczenie” — sprawdzamy te 6 najpierw.

CZAS: 25 min Wiedza diagnostyczna

ŹRÓDŁO: Kraus i wsp. (2018, World Psychiatriy); Briken (2020, Sexual Medicine)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje **6 alternatywnych diagnoz**, które mogą tłumaczyć wzmoczone zachowania seksualne: 1) *epizod maniakalny / hipomania*, 2) *zaburzenia preferencji* (parafilie), 3) *efekt substancji*, 4) *zaburzenie osobowości*, 5) *zespoły organiczne* (np. zespół Tourette'a, niektóre demencje), 6) *parafilie nieuznawane*. Karta pokazuje, jak różnicować, by nie postawić CSBD u kogoś, kto naprawdę ma inne zaburzenie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Briken (2020, *Sexual Medicine Reviews*) podkreśla, że **20-35% pacjentów** zgłaszających „uzależnienie od seksu” lub PPU ma *inne zaburzenie* jako podstawową przyczynę. Dla nich diagnoza CSBD jest **nietrafna** — leczenie powinno celować w zaburzenie podstawowe. Najczęstsze pomyłki: 1) hipomania (CHAD typ II) traktowana jak „uzależnienie seksualne”, 2) zaburzenie borderline z hiperseksualnością jako mechanizmem regulacji, 3) używanie stymulantów (metamfetamina, kokaina) zwiększające popęd. Bez różnicowania pacjent dostaje terapię CBT-PPU, która nie pomaga — bo problem nie jest w PPU.

01 ≡ Sześć diagnoz różnicowych

1 · EPIZOD MANIAKALNY / HIPOMANII

W manii / hipomanii zwiększa się popęd seksualny, eskaluje używanie pornografii. *Klucz różnicujący:* obecność też innych objawów — euforia, mniej snu, gonitwa myśli, grandiozyjność, impulsywne zakupy.

Co robić: diagnoza CHAD przed CSBD; leczenie psychiatryczne.

2 · ZABURZENIA PREFERENCJI (PARAFILIE)

Pedofilia, ekshibicjonizm, fetyszyzm, sadyzm.

Wzorec nie wynika z „utruty kontroli”, tylko z *preferowanego obiektu*. **Wymaga specjalistycznej diagnostyki seksuologicznej i często prawnej.**

Co robić: konsultacja seksuologa sądowego.

3 · EFEKT SUBSTANCJI

Metamfetamina, kokaina, MDMA, niektóre leki (DOPA-agonisty w chorobie Parkinsona) zwiększają popęd.

Klucz: wzmoczone zachowania występują w czasie *używania*, ustępują po abstinencji 4+ tyg.

Co robić: terapia uzależnień + obserwacja po abstinencji.

4 · ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

Borderline (BPD), antyspółeczne (ASPD), narcystyczne (NPD). Hiperseksualność jako część szerszego wzorca: impulsywność, niestabilność, regulacja emocji. CSBD może współistnieć — ale praca skupia się na osobowości.

Co robić: diagnostyka osobowości; ST, DBT, MBT.

5 · ZESPOŁY ORGANICZNE

Zespół Tourette'a, otępienie czołowo-skroniowe, niektóre udary, choroba Parkinsona z DOPA-agonistami. *Klucz:* wystąpienie de novo u dorosłego bez wcześniejszej historii.

Co robić: badanie neurologiczne, MRI, ocena neuropsychologiczna.

6 · NIESPÓJNOŚĆ MORALNA (MI)

Najczęstsza pomyłka. Pacjent z umiarkowanym używaniem + silnym konfliktem moralnym (religia, wartości) doświadcza dystresu wykluczonego z kryteriów CSBD.

Co robić: ACT, praca z wartościami; karta „niespójność moralna”.

02 © Algorytm różnicowania — 4 pytania kluczowe

PYTANIE DIAGNOSTYCZNE	JEŚLI TAK — POMYŚL O	KONSEKWENCJA
Czy zachowanie eskalowało nagle, jest „fala”?	CHAD (mania / hipomania)	Konsultacja psychiatryczna PRZED PPU-terapią
Czy występuje tylko po substancji?	Uzależnienie substancjalne	Terapia uzależnień, obserwacja w abstynencji
Czy obiekt preferencji wydaje się nietypowy (dzieci, przemoc)?	Parafilia	Specjalistyczna seksuologia, czasem prawne
Czy cierpienie wynika TYLKO z konfliktu moralnego?	Niespójność moralna	ACT, praca z wartościami — nie diagnoza CSBD

03 ✎ Twoja samoocena różnicowa

CZY MAM OBJAWY CHAD / HIPOMANII

— euforia, gonitwa, mniej snu, impulsywność

CZY UŻYWAM SUBSTANCJI AKTYWNE

— stymulanty, alkohol, leki dopaminergiczne

CZY MAM DIAGNOZĘ / PODEJRZENIE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

— BPD, NPD, ASPD

CZY MOJE CIERPIENIE WYNIKA TYLKO Z KONFLIKTU MORALNEGO

— wartości / religia / wstyd społeczny

04 💡 Wniosek diagnostyczny

CO Z MOJEJ REFLEKSJI WYNIKA DLA DIAGNOZY

— mogę mieć CSBD / inne zaburzenie / mieszankę / nie wiem, omówię z klinicystą

Klucz: Briken (2020) podkreśla, że **diagnostyka CSBD wymaga 2-4 sesji** z doświadczonym klinicystą — seksuologiem lub psychoterapeutą certyfikowanym w obszarze PPU. „Diagnoza w 30 minut na pierwszej wizycie” jest błędem. Dobra diagnostyka obejmuje: wywiad biograficzny, ocenę współwystępujących zaburzeń, screening narzędziami (np. HBI — Hypersexual Behavior Inventory), w razie potrzeby konsultację psychiatryczną. W Polsce CSBD jest kodowane wg ICD-11 6C72; refundacja w ramach NFZ poradnia seksuologiczna lub poradnia zdrowia psychicznego.